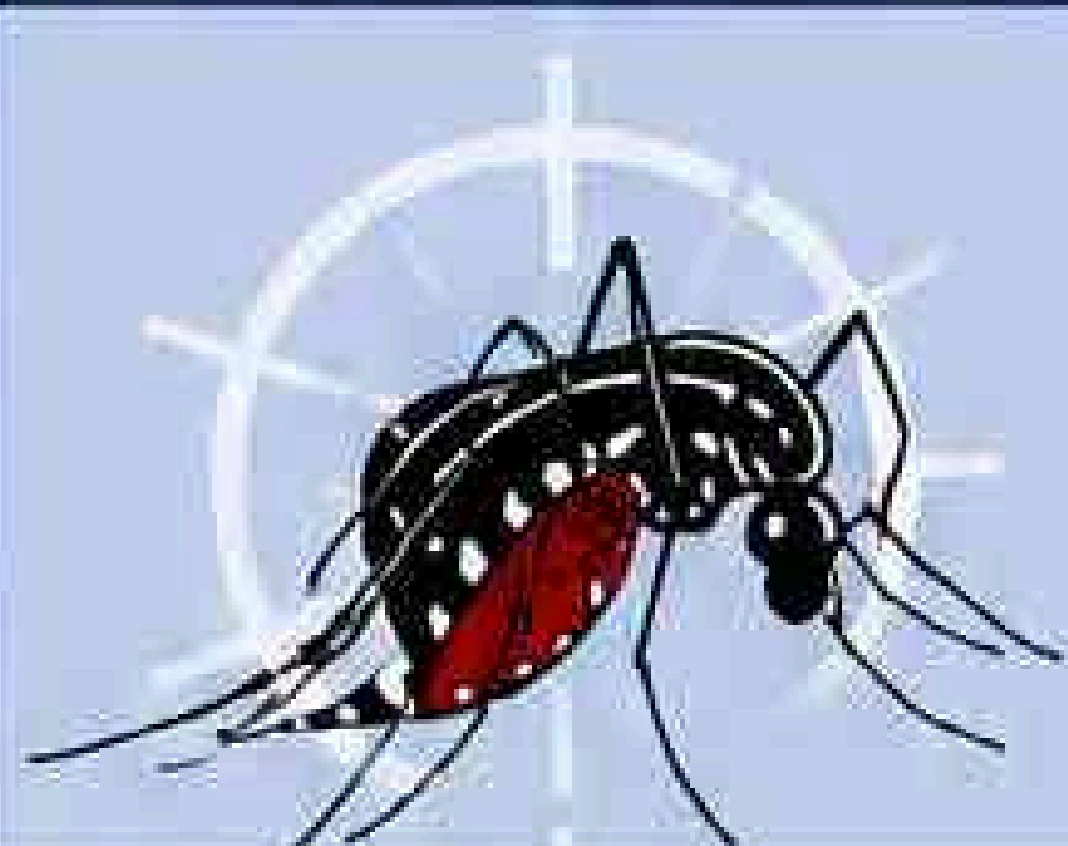




登革熱

DENGUE FEVER



清除孳生源



防蚊措施



早期發現



及早就醫

組員：吳敏瑄、劉虹瑄、林颯岑、林禹辰、吳颯儒

指導老師：曾惠楨

1. 摘要

登革熱 (Dengue Fever) 是由登革病毒引起，透過埃及斑蚊與白線斑蚊叮咬傳播的急性傳染病。近年來全球氣候變遷與國際旅遊頻繁，使得登革熱疫情有擴散的趨勢。本研究旨在探討登革熱的病因、臨床表現、傳播途徑、治療與預防策略，期望能提升對此疾病的認識與防治成效。

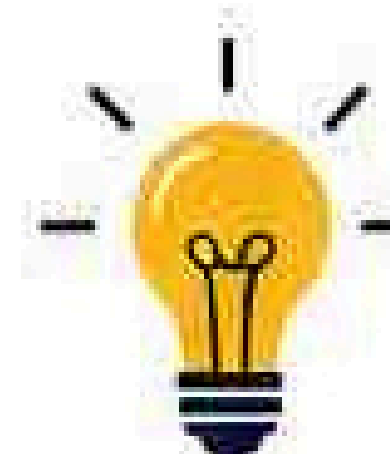


登革熱流行地區 (資料來源：WHO)

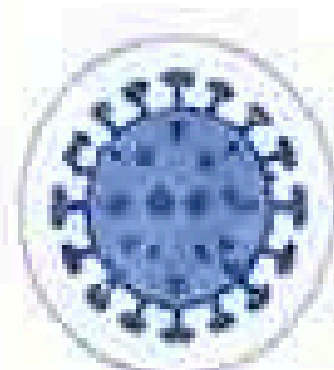
- 環境因素 (如氣溫、降雨、積水容器) 會影響病媒蚊孳生，進而提高登革熱的傳播風險。
- 民眾防蚊知識與衛生態度的知識與行為，與登革熱發生率呈負相關。
- 早期發現與及時就醫可降低重症與死亡風險。

研究假設

加強環境管理與個人防蚊措施，能有效降低登革熱的發生與傳播。



2. 文獻探討



病原體

登革病毒 (DENV) 屬黃病毒科，共有四種血清型 (DENV-1~4)，感染不同型別可能導致嚴重度增加。



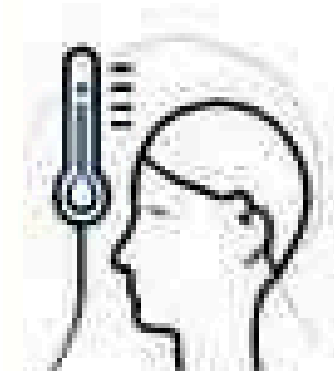
傳播媒介

主要由埃及斑蚊 (Aedes aegypti) 與白線斑蚊 (Aedes albopictus) 傳播，白天活動，以人為吸血對象。



流行病學

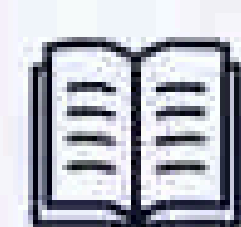
全球超過100個國家地區流行，東南亞、西太平洋及美洲地區疫情嚴重，台灣本土疫情近年有增加趨勢。



臨床症狀

典型症狀：突發高燒、頭痛、後眼痛、肌肉關節痛、出疹。嚴重者可能出現出血、休克，甚至死亡。

3. 研究方法



文獻分析法

蒐集並分析國內外有關登革熱之文獻與研究報告。



問卷調查法

設計問卷了解民眾對登革熱的認知、態度與防治行為。



資料統計分析

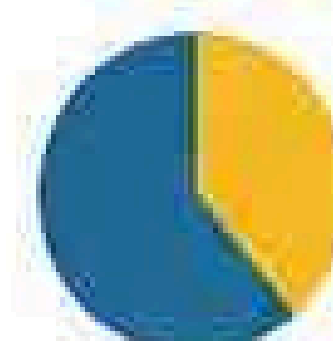
使用統計軟體分析問卷結果，探討變項間的關聯性。



比較分析

比較不同地區、年齡、性別之防治行為差異與感染風險。

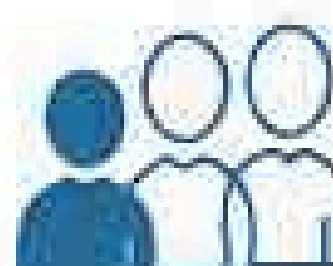
4. 研究結果 (預期)



多數民眾了解登革熱的傳播途徑，但對孳生源清除的落實仍不足。



居住環境整潔度與登革熱發生率呈顯著負相關。



有定期清除積水容器與使用防蚊用品的民眾，感染風險較低。



早期就醫可降低重症發生率與死亡率。

5. 建議與結論

建議

- 落實「巡、倒、清、刷」，定期清除孳生源。
- 加強社區與學校登革熱防治宣導教育。
- 政府應建立長期監測與預警系統。
- 民眾應提高自我防護意識，落實防蚊措施。

結論

登革熱是可預防的疾病。透過環境管理、個人防護與社區合作，能有效降低登革熱的傳播與流行風險，維護公共衛生與全民健康。



6. 登革熱預防小撇步



巡視環境



清除容器



倒掉積水



刷洗容器



防蚊措施

使用防蚊液
穿著長袖衣褲
裝設紗窗紗門

7. 登革熱病程與處理方式

潛伏期
3~14天
(通常4~7天)



發燒期

突發高燒、頭痛、後眼痛、肌肉關節痛、噁心、嘔吐、出疹等



危險期

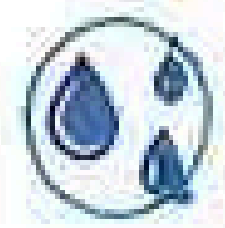
發燒3~7天，可能出現出血、腹痛、嘔吐、器官滲漏等警訊



恢復期

退燒後病情改善，需持續觀察，避免劇烈活動

處理方式



多喝水，充分休息
使用退燒藥
(如普拿登)



儘速就醫，密切監測
避免自行服用阿司匹靈
或非類固醇消炎藥



持續補充水分
避免劇烈運動
追蹤回診

8. 參考文獻

- 衛生福利部疾病管制署 (2024)。登革熱防治專區。取自 <https://www.cdc.gov.tw>
- World Health Organization (2023)。Dengue and severe dengue。取自 <https://www.who.int>
- 黃高彬、楊士隆、盧敬宏 (2020)。登革熱：臨床表現、診斷與治療。台灣醫誌，119(3)，123-130。
- 柯文謙、王任賢 (2021)。臺灣登革熱流行趨勢與防治策略探討。環境與衛生學刊，38(2)，45-52。

